

On distingue 3 types de perturbations des tests hépatiques:

- Tests de **cytolyse hépatocellulaire** : élévation des **transaminases (ASAT, ALAT)**
- Tests de **cholestase** : élévation de la **phosphatase alcaline (PA)**, **bilirubine** et **gamma-glutyl-transférase (GGT)**
- Tests de la **fonction hépatique** : diminution de l'**albumine**, allongement du **temps de prothrombine (TP)**



ALAT, alanine aminotransférase ; DAA, *directly acting antivirals* ; gt, génotype ; PEG-IFN- α , interféron- α pégylé.

Prognostic : Taux de mortalité faible (0,1–0,3%), pas de chronicité ni de portage.

Hépatite B (VHB)

Incubation : 1–6 mois.

Symptômes :

Infection aiguë :

Subclinique dans 70% des cas.

Symptômes possibles : fatigue, myalgies, arthralgies, fièvre, nausées, anorexie, ictère, douleur au quadrant supérieur droit.

Risque de développer une hépatite fulminante (0,5% des cas).

Infection chronique :

La majorité sont des porteurs inactifs, non contagieux.

Possibilité de réactivation avec des symptômes similaires à ceux de l'hépatite aiguë.

Plus le patient est jeune lors de l'infection, plus le risque de chronicité est élevé (90% des nourrissons, 50% des enfants de 1 à 5 ans, 5% des adultes).

Complications : Cirrhose, carcinome hépatocellulaire.

Hépatite C (VHC)

Incubation : 2 semaines à 6 mois.

Symptômes :

Majoritairement asymptomatique.

Peut progresser vers une infection chronique dans la plupart des cas si non traitée.

Les symptômes, s'ils sont présents, sont souvent légers et non spécifiques.

Complications : Risque élevé de développer une cirrhose et un carcinome hépatocellulaire.

Hépatite D (VHD)

Incubation :

Coinfection avec VHB : 1–6 mois.

Surinfection après VHB : 2–8 semaines.

Symptômes :

Similaire à l'hépatite B.

La coinfection avec le VHB entraîne généralement une hépatite aiguë sévère.

La surinfection augmente le risque de cirrhose.

Complications : Cirrhose, aggravation des dommages hépatiques liés au VHB.

Hépatite E (VHE)

Incubation : 2–8 semaines.

Symptômes :

Souvent asymptomatique ou plus léger que l'hépatite A.

Augmentation du risque d'insuffisance hépatique aiguë chez les femmes enceintes.

Complications : Insuffisance hépatique aiguë chez les femmes enceintes.